

TEMA 4.8 • DERMATOLOGÍA

Vitíligo

PERFIL EUNACOM 6.01.1.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Vitíligo (Trastorno Epidérmico Acrómico)

El Vitíligo (o "vitiligo") es una patología crónica de etiología fundamentalmente **Autoinmune** en el que se produce la destrucción o disfunción basal sistémica perjudicial celular de los melanocitos basales de la piel epitelial encargados del pigmento cromático, generándose una despigmentación acelerada y expandida.

Factores Adyacentes Clínicos Obligados en Derivación Endocrinológica

Resulta altamente entrelazado por su origen inmunitario genotípico a un estrés precipitante psico somático profundo, pero se destaca severa y alarmantemente la masiva interrelación secundaria paralela clínica de presentarse cruzado estrechamente a otras serias y graves distrofias crónicas endógenas Autoinmunitarias (muy en particular a los ataques inmunológicos glandulares de tiroides). En consecuencia de su manifestación base de piel, **Todo portador comprobado de Vitíligo en control debe mandatoriamente someterse al tamizaje de screening tiroideo basal** para excluir Tiroides de Hashimoto solicitando niveles de recuento circulantes de **Hormona TSH y los Anticuerpos directos Anti-TPO**.

Cuadro Clínico y Frecuencias Geográficas Topográficas

- **Morfología Patognomónica de la Lesión:** El diagnóstico en consulta es pericial puramente por la visual clínica sin requerirse biopsia directa al manifestar la aparición destructiva expansiva acelerada de incontables y caprichosas **Máculas Acrómicas** lisas (Manchas puramente y en absoluto **Amelanóticas Blancas inmaculadas**, desprovistas por total, absoluto e integro de todo relieve o hipopigmentación atenuada de color remanente amarillento). - **Zonas Predilectas de la Despigmentación:** Arranca comúnmente en márgenes muy reconocibles. 1. *Periorificial Central del Rostro:* Halo de enmascaramiento circunscrito asediando directamente alrededor en torno a los labios de la boca, y perfiles paralelos rodeantes del cerco de los ojos y periorbital. 2. *Las Extensiones Distantes Periféricas - Acrales:* Afectando de preferencia el dorso, pulpejos distales estirados perimetrales anatómicos de base de las **Manos e igual para los Pies**. 3. *Región Pélvica y Genital:* *Vulva y márgenes penianos glandulares profundos.*

El Choque Terapéutico Dermatológico

El combate de recuperación epitelial pigmentario frena el desastre inmune basando todo su sustento en apagar por completo a la inmunidad celular regional agresora del cuerpo:

- **Estrategia Basal y Pilar en Manejo de Base Local Tópica de Inicio Leve/Moderada Controlada:** Corresponde sin atenuantes al asedio frotado regional por largos cursos estrictos continuados en el plazo de extensas semanas de un **Corticoide Tópico de Muy Alta Potencia**

inmunosupresora focal, despuntando masivamente el Clobetasol crema recetado de rutina en choque, rotado subsidiariamente como segunda línea conservadora si hay atrofia delgadas limitantes al inmunomodulador celular no corticoideo sistémico tópico celular **Tacrolimus dérmico estricto en pomadas**.

- **Estrategia Agresiva Inmunológica Hospitalaria de Avance o Destrucción Descontrolada Masiva de Rescate EUNACOM:** Los raros genotipos con comportamiento biológico feroz y rápido de ensanche acelerado diario en cara, sin cese al freno tópico, imponen sin reservas **Derivación inmediata de Alta Prioridad**. La demora se traduce insoslayablemente letal estéticamente, porque se solidifica permanentemente el blanco celular irreversible final. El arsenal exige **Frenador inmunosupresor sistémico Vía Oral general estacional (Corticoides orales centrales sistémicos Prednisona)** en conjunto de las temidas ráfagas del estricto tratamiento oncológico directo citotóxico controlado en la **Fototerapia masiva corporal (radiaciones de onda regulada y constante ultravioleta de gabinete clínica médica PUVA / luz UVB)** bajo resguardo y dirección dermatológica.

(Alineado el control crónico perimetral y como terapia suplementaria estética aliviadora psicoterapéutica subyacente sin efectos activos biológicos curativos, el uso reglado del camuflaje externo, tinciones de maquillaje tinturador cosmético focal se ofrece constantemente y aporta consuelo estético pasivo temporal).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la característica más importante de las lesiones del vitíligo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Vitíligo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El vitíligo produce máculas acrónicas o completamente amelanóticas, no solo hipopigmentadas.
- El vitíligo es autoinmune y se asocia especialmente al hipotiroidismo de Hashimoto.
- La distribución característica incluye zona periocular, peribucal, manos, pies y genitales.
- La lámpara de Wood acentúa las máculas acrónicas y es útil para confirmar el diagnóstico.
- Los corticoides tópicos de alta potencia y la fototerapia UVB son el tratamiento principal.
- En vitíligo agresivo se combinan corticoides orales con fototerapia para detener la progresión.
- Siempre buscar enfermedades autoinmunes asociadas, especialmente el hipotiroidismo de Hashimoto.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VITÍLIGO)

PREGUNTA 1

¿Cuál es la característica más importante de las lesiones del vitíligo?

- A)** Son lesiones hipopigmentadas con algo de pigmento residual visible
- B)** Son lesiones acrónicas completamente amelanóticas sin ningún pigmento
- C)** Son lesiones eritematosas con escamas finas superficiales
- D)** Son lesiones con bordes irregulares y cambio de color hacia rojo
- E)** Son lesiones que aparecen solo en zonas expuestas al sol directamente

PREGUNTA 2

¿Con qué enfermedad autoinmune se asocia principalmente el vitíligo?

- A)** La artritis reumatoide con compromiso articular simétrico
- B)** El lupus eritematoso sistémico con compromiso multiorgánico
- C)** El hipotiroidismo de Hashimoto con anticuerpos antitiroideos
- D)** La espondilitis anquilosante con compromiso de columna vertebral
- E)** La diabetes mellitus tipo uno con anticuerpos anti-islotos pancreáticos

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento indicado para casos de vitíligo con rápida progresión?

- A)** Solo corticoides tópicos de alta potencia aplicados dos veces al día
- B)** Fototerapia UVB de banda estrecha como único tratamiento efectivo
- C)** Corticoides orales combinados con fototerapia para detener la progresión
- D)** Inmunosupresores como metotrexato o azatioprina en monoterapia
- E)** Inhibidores de JAK tópicos sin ninguna otra medida adicional

RESUMEN: VITÍLIGO

El vitíligo es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmune destruye selectivamente los melanocitos, produciendo máculas acrónicas o amelanóticas, es decir, completamente despigmentadas y sin melanina. Este es el dato más importante: las lesiones del vitíligo son acrónicas, no solo hipopigmentadas. La distribución característica es periocular, peribucal, manos y pies, y genitales. Al ser autoinmune, se asocia a otras enfermedades autoinmunes, especialmente el hipotiroidismo de Hashimoto, por lo que siempre debe buscarse. El diagnóstico es clínico y se puede confirmar con lámpara de Wood que acentúa las máculas acrónicas. El tratamiento incluye corticoides tópicos de alta potencia como el clobetasol, fototerapia UVB de banda estrecha o UVA con psoraleno. En casos agresivos con rápida progresión se pueden usar corticoides orales junto a fototerapia para detener el avance. El vitíligo produce un impacto psicológico importante, especialmente en personas de piel oscura donde el contraste es más llamativo.